SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

职场大粪同事与急性躁狂发作相关性的多中心横断面研究分析

勤屎皇 [1,*]
大粪自然科学基金
[1]化粪池医科大学附属医院 心理精神科 化粪池市 大粪国
通讯作者：勤屎皇（e-mail:863273500@qq.com）
本研究由大粪国家青年基金基金资助（项目编号：20609603）

ABSTRACT / 摘要 为探究职场人际应激（糟心事）与急性躁狂发作的相关性及诱发机制，本研究以多中心临床确诊的急性躁狂发作患者为研究对象，结合临床病例资料、心理测评结果及职场应激源调查数据，分析职场人际糟心事的暴露情况、严重程度与急性躁狂发作的发病风险、症状严重程度的关联，并挖掘其背后的生物-心理-社会介导路径。结果显示，职场人际糟心事是急性躁狂发作的独立危险因素，高暴露度、长持续时间的职场人际冲突会使躁狂发作发病风险提升，且与躁狂症状严重程度呈正相关；神经内分泌紊乱、认知评价偏差及社会支持系统破坏是其核心介导因素。本研究为临床识别职场人群躁狂发作高危个体、制定针对性干预策略提供实证依据，也为职场心理健康管理提供参考。

INDEX TERMS / 关键词 职场大粪同事；急性躁狂发作；双相情感障碍；相关性；多中心研究；应激介导机制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

急性躁狂发作是双相情感障碍的急性重症表现，社会心理应激为公认的重要诱发因素，而职场作为成年人核心社会活动场景，人际矛盾、协作扯皮、分工不公等「糟心事」已成为职场人群最主要的慢性应激源之一。现有临床研究多以单病例报道为主，缺乏大样本、多中心的实证数据证实职场人际糟心事与急性躁狂发作的直接相关性，且对二者之间的介导机制、剂量反应关系尚未形成系统结论。

同时，当前职场心理健康管理多聚焦于焦虑、抑郁等情绪问题，对躁狂发作的早期识别与应激源防控重视不足，导致大量因职场人际糟心事诱发的躁狂发作病例漏诊、误诊，患者社会功能严重受损。基于此，本研究通过多中心横断面调查，系统分析职场人际糟心事与急性躁狂发作的相关性，填补该领域研究空白，为临床诊疗与职场心理干预提供实操性依据。

II. RESULTS / 结果

（一）研究对象

选取2024年1月-2025年12月全国12家精神科临床研究中心收治的职场人群急性躁狂发作患者为研究组，共纳入326例；同期选取上述中心周边企业无精神疾病史的职场健康人群为对照组，共纳入652例，采用1:2配比原则，按年龄、性别、职业类型、工作年限进行匹配。

纳入标准：1. 研究组符合《ICD-11》双相情感障碍急性躁狂发作诊断标准，杨氏躁狂量表（YMRS）评分≥16分；2. 所有研究对象均为在职职场人群，工作年限≥1年；3. 意识清晰，能配合完成应激源调查及心理测评；4. 签署研究知情同意书。

排除标准：1. 器质性脑疾病、躯体疾病、精神活性物质所致躁狂样发作；2. 有精神分裂症等其他重性精神疾病

史；3. 近6个月有重大生活事件（如丧亲、离异）非职场应激源暴露；4. 无法配合完成调查或资料不全者。

（二）研究方法

1. 一般资料调查：设计《职场人群基本信息问卷》，收集研究对象年龄、性别、学历、职业类型、工作年限、婚姻状况、家族精神疾病史等资料。

2. 职场人际糟心事评估：自制《职场人际应激源（糟心事）调查量表》，从人际冲突频率（每月发生次数）、冲突持续时间（单次冲突持续天数）、冲突严重程度（轻度口角/中度争执/重度肢体/言语攻击）、应激源类型（分工矛盾/协作扯皮/同事排挤/领导不公）4个维度进行评分，总分0-80分，得分越高表示职场人际糟心事暴露度越高；同时记录应激源暴露至发病的间隔时间。

3. 精神症状测评：采用杨氏躁狂量表（YMRS）评估躁狂症状严重程度（重度≥25分、中度16-24分、轻度＜16分），汉密尔顿焦虑量表（HAMA）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD-17）评估伴随情绪症状。

4. 辅助检查：所有研究对象均完成血常规、肝肾功能、甲状腺功能、头颅CT/MRI、脑电图检查，排除躯体及器质性疾病因素。

5. 统计学方法：采用SPSS 26.0（化粪池定制版）进行数据分析，计量资料以（\bar{x}±s）表示，组间比较采用t检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用\chi^2检验；采用多因素Logistic回归分析探究急性躁狂发作的独立危险因素；采用Pearson相关分析探究职场人际糟心事评分与YMRS评分的相关性；采用中介效应分析验证神经内分泌、认知评价、社会支持的介导作用。检验水准α=0.05，P＜0.05为差异有统计学意义。

（一）两组研究对象一般资料比较

研究组与对照组在年龄、性别、学历、职业类型、工作年限、婚姻状况等一般资料方面比较，差异均无统计学意义（P＞0.05），两组具有可比性；研究组家族精神疾病史阳性率（8.9%）高于对照组（2.3%），差异有统计学意义（P＜0.05），已在多因素分析中进行校正。

（二）两组职场人际糟心事暴露情况比较

研究组职场人际糟心事总评分（58.26±10.35）分，显著高于对照组（21.58±8.62）分，差异有统计学意义（t=42.36，P＜0.001）；研究组每月人际冲突≥3次者占89.6%、单次冲突持续≥3天者占78.5%、重度冲突者占45.1%，均显著高于对照组（分别为23.8%、10.2%、3.7%），差异均有统计学意义（P＜0.001）。

研究组中，职场人际糟心事暴露至躁狂发作间隔时间≤2周者占91.1%，其中以「协作扯皮+同事排挤」复合应激源暴露占比最高（42.3%），其次为分工矛盾（28.8%）。

（三）职场人际糟心事与急性躁狂发作的危险因素分析

多因素Logistic回归分析显示，在校正家族精神疾病史、既往情绪问题后，职场人际糟心事高暴露（OR=5.82，95%CI：4.15~8.18，P＜0.001）、重度人际冲突（OR=4.26，95%CI：2.93~6.19，P＜0.001）、复合应激源暴露（OR=3.95，95%CI：2.78~5.60，P＜0.001）均为急性躁狂发作的独立危险因素。

（四）职场人际糟心事评分与躁狂症状严重程度的相关性

Pearson相关分析显示，研究组职场人际糟心事总评分与YMRS评分呈显著正相关（r=0.72，P＜0.001）；其中冲突频率、严重程度与YMRS评分的相关性系数更高（分别为r=0.68、r=0.75，P＜0.001）。

（五）介导机制分析

中介效应分析显示，职场人际糟心事并非直接诱发急性躁狂发作，而是通过3条路径介导：1. 神经内分泌紊乱（HPA轴亢进、皮质醇升高），中介效应占比35.2%；2. 消极认知评价（过度关注冲突、认知偏差），中介效应占比28.6%；3. 社会支持系统破坏（职场社交隔离、积极互动减少），中介效应占比21.8%，总中介效应占比85.6%。

指标	对照组（n=652）	研究组（n=326）	x^2/t	P
糟心事总分	21.58±8.62	58.26±10.35	42.36	＜0.001
每月冲突≥3次	23.8%	89.6%	356.42	＜0.001
单次冲突≥3天	10.2%	78.5%	412.77	＜0.001
重度冲突	3.7%	45.1%	278.39	＜0.001

III. Discussion / 讨论

（一）职场人际糟心事是急性躁狂发作的独立危险因素
本研究多中心数据证实，职场人际糟心事高暴露是职场人群急性躁狂发作的核心独立危险因素，且存在明显的剂量反应关系——即职场人际冲突越频繁、持续时间越长、严重程度越高，躁狂发作的发病风险越高，这与既往单病例报道结论一致，填补了大样本实证研究的空白。研究发现，91.1%的患者在职场人际糟心事暴露后2周内发病，提示短期高强度的职场人际应激是急性躁狂发作的「扳机点」；而「协作扯皮+同事排挤」复合应激源暴露占比最高，说明多维度的职场人际负面刺激会形成应激叠加效应，更易突破情绪调节阈值，诱发躁狂发作。同时，家族精神疾病史为躁狂发作的易感因素，提示职场人际糟心事作为外部应激源，与内部遗传易感因素共同参与躁狂发作的发生发展，符合「生物-心理-社会」三维发病模型。

（二）职场人际糟心事与躁狂症状严重程度呈正相关
本研究显示，职场人际糟心事评分与YMRS躁狂症状评分呈显著正相关，其中冲突严重程度的相关性最高，提示重度人际冲突（如言语/肢体攻击、恶意排挤）会直接加剧躁狂症状的严重程度，导致患者易激惹、冲动行为更明显，社会功能受损更严重。
这一结果提示临床诊疗中，对职场人际糟心事诱发的躁狂发作患者，不仅要控制躁狂症状，还需评估职场应激源的严重程度，针对性采取应激源隔离措施，避免症状因持续应激而加重。

（三）职场人际糟心事诱发躁狂发作的核心介导机制
本研究明确了神经内分泌紊乱、消极认知评价、社会支持系统破坏是职场人际糟心事诱发急性躁狂发作的三大核心介导路径，总中介效应占比85.6%，说明职场人际糟心事主要通过间接作用诱发躁狂发作：
1. 神经内分泌通路：长期/高强度职场人际应激导致HPA轴功能亢进，皮质醇分泌异常增加，直接干扰中枢多巴胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素等情绪调节神经递质的平衡，导致情绪调节功能紊乱，这是生理层面的核心介导机制；
2. 心理认知通路：职场人群对人际糟心事的消极认知评价（如过度放大矛盾、归因偏差、产生被害感）会加剧焦虑、压抑等负性情绪，长期情绪积压会诱发情绪「反向爆发」，表现为躁狂发作的情绪高涨、易激惹等症状；
3. 社会支持通路：职场人际冲突会破坏患者的职场社交支持网络，导致其产生社交隔离，积极社会互动减少，失去情绪宣泄与心理支持的渠道，进一步加重情绪异常，最终诱发躁狂发作。
三大路径相互作用、彼此叠加，形成「应激暴露-生理紊乱-心理偏差-社会支持缺失-躁狂发作」的链式反应，这为临床制定综合干预方案提供了靶点依据。

（四）临床与职场管理启示
1. 临床诊疗层面：① 早期识别：对职场人群出现的情绪高涨、话多、失眠、易激惹等症状，需常规评估职场人际应激源暴露情况，避免漏诊；② 综合干预：以心境稳定剂+非典型抗精神病药快速控制躁狂症状为核心，同时针对三大介导路径制定靶向干预——通过药物调节神经内分泌、通过认知行为治疗纠正消极认知、通过社会支持重建改善患者社交状态；③ 预后防控：出院后建议患者避免再次接触原职场应激源，必要时协助调整工作岗位，降低复发风险。
2. 职场心理健康管理层面：① 建立职场人际应激筛查体系，对高冲突岗位、高暴露人群进行定期心理测评，早期识别高危个体；② 开展职场情绪管理与冲突化解培训，提升员工的应激应对能力与认知调节能力；③ 完善职场心理支持体系，设立心理疏导通道，及时干预职场人际矛盾，减少应激源的产生与叠加。

（五）研究局限性与展望
本研究为横断面研究，无法明确职场人际糟心事与急性躁狂发作的因果时序关系，后续需开展前瞻性队列研究进一步验证；其次，自制的《职场人际应激源（糟心事）调查量表》虽具有良好的信效度，但尚未形成行业统一标准，后续需进一步修订完善。
未来研究可聚焦于不同职业类型（如行政、互联网、制造业）职场人际糟心事的特征差异，以及针对性的干预方案制定；同时可探索肠道菌群、基因多态性等因素在职场人际糟心事与躁狂发作之间的调节作用，为精准诊疗提供更多依据。

IV. Conclusions / 结论

的职场人际糟心事会显著提升躁狂发作的发病风险，且暴露后2周内为发病高危期；
2. 职场人际糟心事评分与急性躁狂发作的症状严重程度呈显著正相关，冲突严重程度对躁狂症状的影响最明显；
3. 神经内分泌紊乱、消极认知评价、社会支持系统破坏是职场人际糟心事诱发急性躁狂发作的三大核心介导机制，且三者存在叠加效应；
4. 临床对职场人群躁狂发作的诊疗需兼顾症状控制与应激源干预，职场心理健康管理需加强人际应激源的早期筛查与化解，从源头上降低躁狂发作的发病风险。

References

[1] 中华医学会精神病学分会. 中国双相情感障碍防治指南（2020年版）[M]. 北京：人民卫生出版社，2020：89-95.
[2] 张艳，王健. 职场应激与双相情感障碍发作的相关性研究 [J]. 中华精神科杂志，2021，54（3）：215-220.
[3] Bauer M，Pfennig A. Stress and bipolar disorder：A systematic review of molecular mechanisms and gene-environment interactions [J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews，2018，95：183-195.
[4] 李凌江，陆林. 精神病学（第9版）[M]. 北京：人民卫生出版社，2018：112-118.
[5] McIntyre RS，Kramer G，Pavuluri MN. Treatment of acute mania：An update [J]. Current Psychiatry Reports，2020，22（12）：78.